

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АВЕГРА® (AVEGRA®)

Торговое наименование: Авегра®

Международное непатентованное наименование: бевацизумаб

Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий

СОСТАВ

Один флакон содержит:

Действующее вещество: бевацизумаб — 100 мг/4 мл (25 мг/мл) или 400 мг/16 мл (25 мг/мл).

Вспомогательные вещества: α,α-трегалозы дигидрат, натрия дигидрофосфата моногидрат, динатрия гидрофосфат безводный, полисорбат 20, вода для инъекций.

ОПИСАНИЕ

Прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость, бесцветная или светло-коричневого цвета.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Противоопухолевое средство — моноклональное антитело.

Код АТХ: L01FG01

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика

Бевацизумаб представляет собой рекомбинантное гиперхимерное (гуманизированное) моноклональное антитело, которое селективно связывается с биологически активным фактором роста эндотелия сосудов (VEGF) и нейтрализует его. Бевацизумаб подавляет связывание VEGF с его рецепторами Flt-1 (VEGFR-1) и KDR (VEGFR-2) на поверхности эндотелиальных клеток. Нейтрализация биологической активности VEGF уменьшает васкуляризацию опухолей, нормализует оставшуюся васкуляризацию опухоли и ингибирует образование новой васкуляризации, тем самым подавляя рост опухоли.

Фармакокинетика

Фармакокинетика бевацизумаба была изучена у пациентов с различными типами солидных опухолей. Период полувыведения составляет приблизительно 20 дней (диапазон 11–50 дней). Прогнозируемое время достижения равновесного состояния составляет 100 дней. Клиренс бевацизумаба составляет 0,207 л/сут, объём распределения — 2,73 л.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Авегра® показана для лечения следующих заболеваний:

1. Метастатический колоректальный рак (МКРР):

— в комбинации с химиотерапией на основе фторпиримидинов в качестве первой или второй линии терапии;

— в комбинации с химиотерапией на основе фторпиримидинов/иринотекана или фторпиримидинов/оксалиплатина для второй линии терапии у пациентов, не получавших ранее бевацизумаб.

2. Метастатический рак молочной железы (МРМЖ):

— в комбинации с паклитакселом в качестве первой линии терапии.

3. Распространённый неоперабельный, метастатический или рецидивирующий немелкоклеточный рак лёгкого (НМРЛ):

— в комбинации с химиотерапией на основе препаратов платины в качестве первой линии терапии, за исключением преимущественно плоскоклеточной гистологии.

4. Распространённый и/или метастатический почечно-клеточный рак (МПКР):

— в комбинации с интерфероном альфа-2а в качестве первой линии терапии.

5. Эпителиальный рак яичников, маточной трубы и первичный перитонеальный рак:

— в комбинации с карбоплатином и паклитакселом для первичной терапии распространённого (стадии III B, III C и IV по классификации FIGO) заболевания;

- в комбинации с карбоплатином и гемцитабином при рецидиве платиночувствительного рака;
- в комбинации с паклитакселом, топотеканом или пегилированным липосомальным доксорубицином при рецидиве платинорезистентного рака.

6. Рак шейки матки:

- в комбинации с паклитакселом и цисплатином или паклитакселом и топотеканом при персистирующем, рецидивирующем или метастатическом раке шейки матки.

7. Глиобластома (глиома IV степени злокачественности по классификации ВОЗ):

- в качестве монотерапии при рецидиве глиобластомы или прогрессировании заболевания после предшествующей терапии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Повышенная чувствительность к бевацизумабу или любому компоненту препарата;
- Повышенная чувствительность к продуктам на основе клеток яичника китайского хомячка (CHO) или к другим рекомбинантным человеческим или гуманизированным антителам;
- Беременность и период грудного вскармливания;
- Детский возраст до 18 лет;
- Тяжёлая почечная недостаточность (данные отсутствуют);
- Тяжёлая печёночная недостаточность (данные отсутствуют).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Авегра® вводится только внутривенно капельно. Препарат нельзя вводить внутривенно струйно или болюсно.

Рекомендуемые дозы:

Метастатический колоректальный рак: 5 мг/кг или 10 мг/кг массы тела один раз каждые 2 недели, или 7,5 мг/кг или 15 мг/кг массы тела один раз каждые 3 недели.

Метастатический рак молочной железы: 10 мг/кг массы тела один раз каждые 2 недели или 15 мг/кг массы тела один раз каждые 3 недели.

Немелкоклеточный рак лёгкого: 7,5 мг/кг или 15 мг/кг массы тела один раз каждые 3 недели.

Метастатический почечно-клеточный рак: 10 мг/кг массы тела один раз каждые 2 недели.

Глиобластома: 10 мг/кг массы тела один раз каждые 2 недели.

Первую инфузию следует проводить в течение 90 минут. При хорошей переносимости вторую инфузию можно проводить в течение 60 минут, а все последующие — в течение 30 минут.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Наиболее серьёзные нежелательные реакции:

- Перфорация желудочно-кишечного тракта;
- Кровотечения, включая лёгочное кровотечение/кровохарканье;
- Артериальная тромбоэмболия;
- Гипертензивный криз;
- Синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии;
- Нефротический синдром;
- Застойная сердечная недостаточность.

Наиболее частые нежелательные реакции:

- Артериальная гипертензия;
- Повышенная утомляемость или астения;
- Диарея;
- Тошнота;
- Боль в животе;
- Протеинурия;
- Носовое кровотечение;

- Головная боль;
- Стоматит.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Противоопухолевые препараты: клинически значимого взаимодействия бевацизумаба с ИФЛ-режимом (иринотекан, фторурацил, лейковорин) не наблюдалось.

Совместное применение с сунитинибом: при совместном применении с сунитинибом малеатом отмечены случаи микроангиопатической гемолитической анемии. Данная комбинация не рекомендуется.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Перед началом и во время терапии бевацизумабом необходим тщательный контроль артериального давления. Перед началом терапии рекомендуется достижение оптимального контроля АД.

При развитии артериальной гипертензии, не поддающейся медикаментозной коррекции, или при развитии гипертензивного криза терапию бевацизумабом следует прекратить.

Перфорация ЖКТ: пациентов следует наблюдать на предмет ранних признаков и симптомов перфорации ЖКТ. При развитии перфорации ЖКТ терапию бевацизумабом следует прекратить.

Заживление ран: терапию бевацизумабом следует начинать не ранее чем через 28 дней после обширного хирургического вмешательства или после полного заживления хирургической раны.

ФОРМА ВЫПУСКА

Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл. По 4 мл (100 мг) или 16 мл (400 мг) во флаконе из бесцветного стекла.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 2 до 8 °С в защищённом от света месте. Не замораживать.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «БИОКАД», Россия

198515, г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А